Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Otoplastie

Chirurgie de correction des oreilles décollées

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Côté : ☐ Droit ☐ Gauche ☐ Les deux

Type d'anesthésie : ☐ Anesthésie générale ☐ Anesthésie locale ☐ Anesthésie locale + sédation

Parties à corriger / attentes du patient : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Les oreilles décollées sont des oreilles qui s'écartent de la tête selon un angle plus ouvert que la normale, ou dont le pli naturel du cartilage de l'oreille (l'anthélix) ne s'est pas formé. Cette particularité est généralement présente dès la naissance, n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas l'audition. Cependant, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence, elle peut entraîner des moqueries, une perte de confiance en soi et une anxiété sociale.

Le but de l'otoplastie est de rapprocher les oreilles de la tête afin qu'elles aient un aspect **naturel** et soient aussi **équilibrées** que possible des deux côtés. Comme l'oreille atteint l'essentiel de sa taille adulte vers l'âge de 5–6 ans, l'opération peut être réalisée **à partir de 5–6 ans** ; la réaliser avant l'âge scolaire peut éviter que l'enfant en souffre sur le plan social. Si votre enfant doit être opéré, il est important de tenir compte de son propre souhait et de sa disposition à le faire.

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'opération est réalisée au bloc opératoire. Chez l'enfant, on utilise généralement une anesthésie générale ; chez l'adulte, une anesthésie locale (avec sédation si nécessaire) ou une anesthésie générale.

1. **Planification et marquage :** Les oreilles sont photographiées, leur distance par rapport à la tête est mesurée et l'emplacement du nouveau pli est marqué.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Incision :** Une incision est pratiquée dans la peau, **à l'arrière de l'oreille**, près du pli naturel situé entre l'oreille et la tête. Cette cicatrice se trouvant derrière l'oreille, elle n'est généralement pas visible.
3. **Remodelage du cartilage :** Un nouveau pli (anthélix) est créé dans le cartilage de l'oreille à l'aide de points de suture permanents. Si nécessaire, le cartilage est aminci ou légèrement strié pour l'assouplir.
4. **Rapprochement de l'oreille :** Si la partie creuse profonde de l'oreille (la conque) est grande, elle est réduite ou fixée par des points aux tissus situés derrière l'oreille. Si le lobe de l'oreille est également décollé, il est corrigé.
5. **Fermeture et pansement :** La peau est refermée par des points de suture. Un pansement de tête souple et légèrement compressif est mis en place pour maintenir la nouvelle forme des oreilles et éviter une accumulation de sang.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale chez l'enfant ; anesthésie locale ± sédation ou anesthésie générale chez l'adulte	Environ 1–2 heures (les deux côtés)	Sortie généralement le jour même

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Des oreilles plus proches de la tête, d'aspect naturel
- Un aspect plus équilibré entre les deux oreilles
- Moins d'anxiété sociale et de moqueries liées à l'apparence ; un regain de confiance en soi

La plupart des patients et des familles sont satisfaits du résultat. Le cartilage de l'oreille étant un tissu souple, les publications indiquent que chez environ **5–10 patients sur 100**, l'oreille peut se décoller à nouveau en partie et une correction peut être nécessaire. Des différences de quelques millimètres entre les deux oreilles sont considérées comme normales.

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas se faire opérer :** Les oreilles décollées ne posent pas de problème de santé ; l'opération n'est donc pas indispensable.
- **Modelage (conformateur) pendant la période néonatale :** Au cours des premières semaines après la naissance, le cartilage de l'oreille est très souple et peut être modelé à l'aide de conformateurs spéciaux ; cette méthode n'est plus efficace après cette période.
- **Camouflage par la coiffure :** Des coiffures qui couvrent les oreilles peuvent masquer leur aspect.
- **Techniques sans incision / par fils :** Chez certains patients dont le cartilage est souple, la correction peut être réalisée par de très petites incisions ; le taux de récidive peut être plus élevé qu'avec la chirurgie classique.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'opération n'est pas réalisée, la forme des oreilles restera la même ; elle ne s'améliore pas d'elle-même avec le temps. Les oreilles décollées ne présentent aucun danger pour la santé ; la décision d'opérer dépend entièrement de l'apparence et du souhait de la personne (pour les enfants, de l'enfant et de sa famille).

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Les analyses de sang nécessaires sont réalisées avant l'opération ; si une anesthésie générale est prévue, vous/votre enfant serez examiné(s) par le médecin anesthésiste.
- En cas d'anesthésie générale ou de sédation, il ne faut rien manger ni boire pendant les **6–8 heures** précédant l'opération (pour les jeunes enfants, selon le délai indiqué par le médecin anesthésiste).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Lavez les cheveux avec un shampooing le matin de l'opération. Les cheveux longs peuvent être attachés de façon à être tenus à l'écart de la zone opérée.
- L'opération peut être reportée en cas d'infection cutanée active, d'eczéma ou de plaie de piercing non cicatrisée autour de l'oreille.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

48 premières heures	Des élancements, une sensation de tension et une douleur modérée au niveau des oreilles peuvent survenir ; ils sont soulagés par des antalgiques. Il est recommandé de dormir la tête surélevée. **Une douleur intense d'un seul côté, qui ne cesse d'augmenter, n'est pas normale** et doit être signalée immédiatement.
2e–7e jour	Le pansement est généralement retiré lors d'une consultation de contrôle **entre le 2e et le 5e jour** et les oreilles sont examinées. À ce stade, un gonflement, des ecchymoses et une sensibilité des oreilles sont fréquents. Après le retrait du pansement, un **bandeau** souple est porté. Les enfants peuvent généralement retourner à l'école au bout d'une semaine.
1re–2e semaine	Le bandeau est porté **jour et nuit pendant les 1–2 premières semaines**, puis **uniquement la nuit pendant 4–6 semaines**. Cela évite que l'oreille ne se replie vers l'avant pendant le sommeil et protège les points de suture. Les points cutanés non résorbables, s'ils ont été utilisés, sont retirés entre le 7e et le 10e jour.
3e–6e semaine	La plus grande partie du gonflement disparaît. Les sports de contact, la natation et les casques qui appuient sur les oreilles doivent être évités pendant au moins **4–6 semaines**.
3e–6e mois	Les plis de l'oreille se stabilisent, la cicatrice s'estompe et l'aspect définitif apparaît. Le léger engourdissement des oreilles s'améliore généralement pendant cette période.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Douleur, élancements et sensation de tension les premiers jours
- Gonflement et ecchymoses des oreilles (1–2 semaines)
- Engourdissement temporaire de la peau de l'oreille et sensibilité au froid (quelques semaines à quelques mois)

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Une fine cicatrice derrière l'oreille, qui s'estompe avec le temps

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Points de suture palpables ou ressortant à travers la peau** — Chez environ **5–10 patients sur 100**, les points permanents qui modèlent le cartilage peuvent, des mois ou des années plus tard, être sentis derrière l'oreille, ressortir à travers la peau ou former une petite boule inflammatoire (granulome). Cela se corrige généralement par un geste simple de retrait du fil.
- **Récidive partielle (l'oreille se décolle à nouveau)** — Chez environ **5–10 patients sur 100**, l'oreille peut revenir en partie vers sa position initiale ; une correction peut être réalisée si nécessaire.
- **Légère asymétrie** — Les deux oreilles ne sont jamais exactement identiques ; des différences de quelques millimètres après l'opération sont normales. S'il existe une différence visible, elle peut être corrigée.

Situations peu fréquentes

- **Collection de sang dans l'oreille (hématome)** — Survient chez environ **1–3 patients sur 100**, généralement au cours des 48 premières heures. **Une douleur intense d'un seul côté, qui ne cesse d'augmenter** en est le signe le plus important. L'hématome doit être **drainé en urgence**, avant qu'il ne compromette la vascularisation du cartilage ; si le traitement est retardé, des lésions du cartilage et une déformation définitive (« oreille en chou-fleur ») peuvent apparaître.
- **Infection de la plaie** — Survient chez environ **1–5 patients sur 100** ; elle guérit généralement sous antibiotiques.
- **Cicatrice épaisse ou chéloïde** — Chez environ **1–3 patients sur 100**, en particulier chez les personnes à peau foncée ou ayant une tendance aux chéloïdes, une cicatrice épaisse et en relief peut se former derrière l'oreille. Elle peut nécessiter un traitement par injections de corticoïdes, gel de silicone ou chirurgie, et peut récidiver. Merci de nous signaler si vous avez déjà eu une chéloïde.
- **Hypercorrection ou aspect non naturel** — Les oreilles peuvent paraître trop plaquées contre la tête, le pli peut être trop marqué, ou la partie moyenne de l'oreille peut se trouver plus en arrière que les parties supérieure et inférieure (aspect en « combiné de téléphone ») ; une chirurgie de correction peut être réalisée si nécessaire.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Inflammation de l'enveloppe du cartilage (périchondrite)** — Survient chez **moins de 1 patient sur 100**. Elle se manifeste par une rougeur, un gonflement, une chaleur et une douleur intense croissants au niveau de l'oreille. Elle peut nécessiter des antibiotiques par voie intraveineuse et, si nécessaire, un nettoyage chirurgical ; si le traitement est retardé, une perte de cartilage et une **déformation définitive** peuvent en résulter.
- **Défaut de vascularisation de la peau ou du cartilage (nécrose)** — Très rare ; généralement lié à un pansement trop serré, à un hématome non traité ou à une infection. Des soins de plaie et parfois une chirurgie réparatrice peuvent être nécessaires.
- **Diminution définitive de la sensibilité ou douleur chronique** — L'engourdissement de la peau de l'oreille ou une douleur par temps froid peuvent rarement être définitifs.
- **Rétrécissement du conduit auditif** — Très rarement, après une réduction ou une fixation de la conque, l'entrée du conduit auditif peut se rétrécir ; une correction peut être nécessaire.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Douleur intense de l'oreille d'un seul côté qui ne cesse d'augmenter** (en particulier pendant les 48 premières heures) — cela peut être le signe d'une collection de sang
- Saignement de plus en plus important à travers le pansement, ou pansement imbibé de sang
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, rougeur, gonflement ou chaleur croissants, ou écoulement malodorant de l'oreille
- Pansement qui semble trop serré, ou oreille qui bleuit ou change de couleur
- Un coup sur l'oreille ou une modification soudaine de sa forme

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Ne mouillez pas le pansement et ne le retirez pas vous-même avant qu'il ne soit retiré au cabinet. Une fois le pansement retiré, vous pourrez prendre une douche avec précaution à partir du jour indiqué par votre médecin.
- Portez le bandeau régulièrement pendant la durée indiquée ; c'est important pour un résultat durable.
- Pendant les premières semaines, évitez de vous coucher sur les oreilles, de replier les oreilles vers l'avant et d'enfiler ou d'enlever des vêtements à col serré en forçant sur les oreilles.
- Protégez les oreilles du soleil et du froid intense pendant au moins 3 mois ; en raison de la diminution de la sensibilité, une brûlure ou une gelure peut passer inaperçue.
- Surveillez votre enfant pour qu'il ne tire pas sur le pansement ou le bandeau.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que le port du bandeau pendant la durée recommandée après l'opération contribue au résultat, et que le non-respect de ces consignes peut augmenter le risque de récidive.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.